



RESUMO DE AULA · AULA LIVRE

Tratamento dos transtornos alimentares

Por que os casos vão aumentar, o que separa transtorno alimentar de comer transtornado, e o que um tratamento bem feito pode e não pode prometer.

PROFESSOR E PSICÓLOGO CLÍNICO

Júlio Gonçalves

MSc · CRP 12/17614

Aprenda muito mais na

Comunidade Lógica Psicológica

Uma comunidade para quem quer:

- Ψ **Aprofundar o raciocínio clínico** com conteúdos que unem ciência, processos e análise funcional.
- Ψ **Estruturar uma prática ética e coerente**, com pensamento crítico e evidências atualizadas.
- Ψ **Desenvolver o self clínico** por meio de supervisão, leituras guiadas e construção em rede.

[Clique aqui e saiba mais](#)



O ESSENCIAL

- Ψ **Os casos estão voltando a crescer.** A oscilação dos padrões estéticos e a difusão de medicamentos para emagrecer têm sido acompanhadas de aumento na busca por tratamento.
- Ψ **Entre o diagnóstico e a normalidade há um território enorme.** O *comer transtornado* — sofrimento e prejuízo sem preencher todos os critérios — é o que mais aparece no consultório.
- Ψ **A distorção da imagem corporal é o critério que separa.** Sem ela, o quadro pode ser outro: obsessivo, psicótico, gastrointestinal. Investigue antes de aceitar o diagnóstico que chegou pronto.
- Ψ **O modelo transdiagnóstico organiza o tratamento em torno de quatro processos:** perfeccionismo clínico, imagem corporal e autoestima, dificuldades interpessoais e regulação emocional.
- Ψ **Prevenção de recaída não é possibilidade — é certeza.** Trabalhe desde o início, e não como tópico final que sobra para a última sessão.

Por que estudar isso agora

A aula abre com um recado direto a quem atende: **estudem transtornos alimentares**. A demanda vai aparecer no consultório, se já não estiver aparecendo.

O argumento é histórico. Nas últimas duas décadas o padrão estético oscilou — da magreza extrema do início dos anos 2000, para a valorização da musculatura, e de volta à magreza nos últimos anos, agora impulsionada pela difusão de medicamentos para emagrecer. Cada virada tem correspondência clínica, e a atual vem acompanhada de **aumento na procura por tratamento**.

O ambiente digital funciona como vetor. Comunidades que exaltam a magreza e incentivam a restrição migraram dos blogs dos anos 2000 para as redes de vídeo curto — com público majoritariamente adolescente, e com adultos em posição de influência afirmando que magreza é sinônimo de beleza, de sucesso e de felicidade.

Um caso que ilustra a urgência

Foi relatada, sem identificação, a internação de uma adolescente por anorexia em quadro grave, com previsão de permanência longa e escolarização feita dentro do hospital. Não é caso raro nem distante — é o tipo de situação que chega a partir da escola, da família ou do pediatra, e para a qual o psicólogo clínico precisa estar preparado.

Transtorno alimentar × comer transtornado

A distinção mais útil da aula, e a que mais muda a prática.

- Ψ **Transtornos alimentares** — anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar. Ligados à imagem corporal, ao peso e à dieta.
- Ψ **Transtornos da alimentação** — ruminação, transtorno alimentar restritivo/evitativo, pica. Não estão ligados à imagem corporal, e por isso a área os trata como categoria distinta, ainda que o manual os reúna no mesmo capítulo.
- Ψ **Comer transtornado** — sofrimento e prejuízo relacionados ao corpo e à comida **sem preencher todos os critérios** de nenhum transtorno. Formalmente entra como transtorno alimentar não especificado.

A metáfora da peneira

Os critérios do manual para transtornos alimentares são **categóricos** — uma peneira fechada. Só passa quem tem gravidade. O resultado prático é que **a maior parte das pessoas que procura o consultório sofrendo com o corpo e com a comida não passa nessa peneira** — e fica no território do comer transtornado, que não é diagnóstico e nem por isso é pouco.

Estimativas citadas em aula sugerem que uma parcela expressiva das mulheres apresente algum grau de comer transtornado. Não há estudos de prevalência confiáveis, justamente porque não é categoria diagnóstica — o que é, em si, parte do problema.

Foi levantada também uma crítica cultural: o uso de medicamentos para emagrecer sem indicação, e a apropriação de condições clínicas como justificativa estética. Alguém visivelmente magra que toma medicação para emagrecer ainda mais, com um discurso técnico para explicar a escolha, provavelmente não tem transtorno alimentar diagnosticável — mas é candidata a comer transtornado, e o discurso não deve encerrar a investigação.

Os três quadros, e o que os separa

Anorexia nervosa

Restrição da ingestão energética que leva a peso significativamente baixo para idade, sexo e estágio de desenvolvimento; **medo intenso de ganhar peso**; e perturbação na forma como a pessoa vivencia o próprio peso e a forma corporal. O baixo peso é critério necessário — sem ele, o caso vai para transtorno não especificado, ainda que todo o resto esteja presente.

Dois subtipos: **restritivo** e **purgativo**. E uma observação de nomenclatura: “nervosa” vem de terminologia do século XIX; não há ausência de apetite — há **recusa alimentar apesar da fome**.

Bulimia nervosa

Episódios recorrentes de compulsão alimentar seguidos de **comportamentos compensatórios**, com preocupação com peso e forma corporal. O peso costuma estar na faixa normal ou acima — **não há critério de peso**, e é justamente isso que a separa da anorexia de subtipo purgativo.

Transtorno da compulsão alimentar

Episódios de compulsão **sem** comportamentos compensatórios. Culpa, vergonha, desconforto físico e tristeza aparecem — mas não há tentativa de “desfazer” o episódio. Foi o último dos três a ser reconhecido formalmente como diagnóstico, o que ajuda a explicar por que ainda é o menos conhecido.

Como se define um episódio de compulsão

Consumo, em intervalo curto, de quantidade de alimento claramente maior do que a maioria das pessoas consumiria em circunstâncias semelhantes, **acompanhado de sensação de perda de controle** e, em geral, de culpa intensa.

Os dois elementos são necessários. Comer muito num rodízio ou numa ceia, com prazer e na companhia de outros, não é episódio de compulsão. Comer sozinho, escondido, seguido de culpa e de vontade de sumir, provavelmente é.

A gravidade dos três quadros é graduada no manual — por faixas de índice de massa corporal na anorexia, e por frequência semanal dos comportamentos na bulimia e na compulsão. Os limiares estão no DSM-5-TR e não são reproduzidos aqui.

O argumento pelo espectro

Os autores do modelo transdiagnóstico defendem que os transtornos alimentares deveriam ser tratados como **espectro**, e não como três categorias estanques. O argumento é a trajetória de vida: é comum a mesma pessoa transitar entre os diagnósticos ao longo dos anos — restrição na adolescência, métodos compensatórios na vida adulta jovem, compulsão sem compensação mais tarde. Quem atende adultos ouve essa história com frequência.

A lógica da anorexia, e o diagnóstico diferencial

A anorexia inverte uma lógica que parece óbvia. Compulsão alimentar é compreensível por analogia — todo mundo já comeu demais alguma vez. Já a escolha de **não comer tendo fome intensa e comida disponível**, sustentada até o mal-estar físico, escapa à experiência comum.

É por isso que a reestruturação cognitiva clássica costuma emperrar: a crença não cede a evidência. Ela funciona como **ideia sobrevalorada** — uma ideia prevalente que move o comportamento —, e

diferentemente do que ocorre no TOC, quase sempre **sem insight**. A paciente não reconhece o baixo peso nem a gravidade do próprio comportamento.

Historicamente se acreditou que o quadro pertencesse ao espectro da psicose, justamente pela rigidez da ideia. Hoje se sabe que não — embora antipsicóticos possam ser recurso farmacológico, por reduzirem a intensidade da ideia sobrevalorada e, em alguns casos, por efeito sobre o apetite.

O critério que faz o diagnóstico diferencial

A **perturbação da imagem corporal** é o que separa anorexia e bulimia de outros quadros. Foi relatado o caso, desidentificado, de uma adolescente encaminhada com diagnóstico de anorexia que restringia drasticamente a alimentação — mas por **medo de contaminação**, não por medo de engordar. Perguntada diretamente, dizia estar satisfeita com o próprio corpo. O quadro era outro.

A regra prática: paciente que restringe ou purga **sem** preocupação com peso e forma corporal exige investigação de outra hipótese — obsessiva, psicótica, gastrointestinal. Não aceite o diagnóstico que chegou pronto no encaminhamento.

Há ainda um sinal comportamental observável e útil: quem tem incômodo com o próprio corpo **esconde o corpo** — roupas largas, mangas compridas, agasalho em dia quente. Quem gosta do próprio corpo não o esconde. Não é critério diagnóstico, mas é dado clínico que raramente mente.

Sobre a mortalidade

Uma precisão que vale fazer

Foi dito em aula que a anorexia é o transtorno mental que mais mata, com taxa de mortalidade que chegaria a 10%. O ponto de fundo está correto e é grave: a anorexia tem **a maior mortalidade entre os transtornos mentais**, e mata tanto por complicações clínicas da desnutrição quanto por suicídio.

A cifra de 10%, porém, vem de estudos mais antigos. A síntese contemporânea expressa o risco como **razão de mortalidade padronizada** — cerca de seis vezes a mortalidade esperada para a idade (Arcelus et al., 2011). É menos impactante como número e mais defensável como afirmação, o que importa quando se ensina.

Comorbidades a rastrear

Ψ **Depressão e ansiedade** — tão frequentes que o rastreio deve ser automático diante de qualquer um dos três diagnósticos.

Ψ **Transtornos de personalidade**, em parcela expressiva dos casos, com destaque para o quadro *borderline* — em que a instabilidade da imagem de si favorece a convergência.

Ψ **Uso indevido de substâncias**, com atenção particular a estimulantes prescritos para outras finalidades, usados pelo efeito sobre o apetite.

Sobre esse último ponto, a aula trouxe um relato desidentificado de desfecho catastrófico: uma pessoa próxima que combinou jejum, estimulante anoréxico e álcool, sofreu evento cardíaco grave e ficou com sequelas neurológicas permanentes. O uso desses recursos não é excentricidade adolescente — é risco de morte.

O modelo transdiagnóstico: quatro processos

O tratamento apresentado como padrão de referência é o modelo transdiagnóstico desenvolvido por Fairburn e Cooper — terapia cognitivo-comportamental que trata **independentemente do diagnóstico**, por atuar sobre processos comuns aos três quadros.

1. Perfeccionismo clínico

Presente sobretudo na anorexia e na bulimia, e também em boa parte dos casos de compulsão — em que a busca por alimentação perfeita produz restrição e, depois, descontrole.

A descoberta que organiza o quadro

Apessoa perfeccionista quer controlar tudo, e a vida não colabora. Mas há **uma variável que parece perfeitamente controlável**: o próprio peso. A relação entre o que se ingere e o que a balança mostra é imediata e aritmética — e essa previsibilidade fascina.

Entender isso muda a conduta: não se está diante de vaidade, e sim de alguém que encontrou, num terreno de descontrole generalizado, o único lugar onde sente domínio. Tirar esse controle sem oferecer outro é pedir muito.

2. Imagem corporal e autoestima

Insatisfação com a imagem, baixa autoestima e distorção na percepção do próprio corpo.

3. Dificuldades interpessoais

São pacientes muito afetados pela percepção alheia. E há um agravante cultural nomeado com clareza: **no Brasil se comenta o corpo dos outros com naturalidade** — inclusive o de crianças e adolescentes. Um comentário casual sobre o corpo pode desencadear um dia inteiro de restrição, compensação ou exercício excessivo.

Por isso a **psicoeducação familiar** é parte do tratamento — não a terapia familiar sistêmica, mas o trabalho de orientar a família para que não reforce o transtorno com a melhor das intenções.

4. Regulação emocional

A comida é a principal fonte de regulação emocional das pessoas em geral, com ou sem transtorno — e isso é aprendido cedo, quando se oferece algo gostoso para consolar uma criança. Não é problema em si. Vira problema quando **generaliza**: qualquer desconforto passa a pedir comida.

O objetivo do tratamento é **ampliar o repertório**, para que a regulação não dependa exclusivamente da alimentação.

Fases do tratamento, alta e expectativas

Engajamento e formulação

A primeira fase é a mais difícil, sobretudo na anorexia: a paciente acredita que não tem problema, que está bem, e vê o terapeuta como **mais alguém tentando sabotar o projeto de emagrecer**. Construir aliança aqui é pré-requisito, não etapa.

Segue-se a formulação colaborativa, com psicoeducação sobre mecanismos concretos — por exemplo, que passar o dia sem comer aumenta a chance de episódio compulsivo à noite, ou que o vômito autoinduzido não elimina o que foi ingerido, porque a absorção começa antes do estômago.

Estabilização da alimentação

O objetivo central não é ganhar nem perder peso — é **regularidade**. Sai o ciclo de restrição seguida de excesso, entra um padrão estável. Em alguns casos isso implica ganho de peso; em outros, não.

Estabilizar não significa comer mais: significa comer de forma mais previsível.

Automonitoramento

Componente da TCC clássica, com a mesma lógica do registro de pensamentos: não é para durar a vida inteira em papel, é para ser **incorporado**. Serve tanto ao tratamento quanto à manutenção dos ganhos.

O tema é controverso — há divergência entre profissionais quanto a incluir o acompanhamento de peso, dado que qualquer medida disponível na prática é imprecisa. A discussão existe e deve ser feita caso a caso, com a equipe.

Critérios de alta

Diferentemente de outros quadros, aqui os critérios de alta são **objetivos**. Na bulimia, a interrupção completa dos comportamentos compensatórios é condição mínima. Na anorexia, atingir peso adequado para idade e estatura e sustentar um padrão alimentar regular.

A expectativa que precisa ser alinhada

Um tratamento bem feito **não transforma alguém com anorexia grave em alguém despreocupado com comida**. O que ele faz é tirar a pessoa da inanição e levá-la a um comer estruturado — que pode continuar sendo bastante controlado.

Isso precisa ser dito ao paciente, à família e a si mesmo. Expectativa desalinhada produz sensação de fracasso num tratamento que está funcionando.

Distorção da imagem: conviver, não zerar

A distorção acompanha o paciente e provavelmente **não será eliminada** — até porque não é zero nem em quem não tem transtorno. A demonstração usada em aula foi eloquente: quase todos já se viram num vídeo inesperado e levaram um susto, porque o que se vê no espelho é a **representação mental** do próprio corpo, não o corpo.

Daí a conduta: estabelecer **critérios objetivos externos** — o caimento de uma peça de roupa, por exemplo — em vez de depender da percepção visual diante do espelho.

Prevenção de recaída, desde o início

O ponto mais enfático do encerramento: em transtornos alimentares, recaída **não é possibilidade, é certeza**. Vai haver um evento de vida — um casamento, uma pressão estética, um período difícil — em que o comportamento antigo se apresentará como solução.

Por isso a prevenção de recaída não pode ser o tópico esquecido das últimas sessões. Ela é trabalhada desde o começo, e o paciente precisa sair sabendo manejar o momento em que isso acontecer.

O debate sobre a Terapia Baseada em Processos

A última parte do encontro foi uma discussão franca sobre a TBP, e vale registrá-la inteira porque é rara — duas pessoas discordando sobre ideias, sem transformar isso em disputa pessoal.

A posição da convidada

- Ψ **Falta base empírica própria.** Há um ensaio clínico em andamento, ainda sem resultados publicados. Enquanto isso, a afirmação de superioridade sobre os modelos atuais não está demonstrada.
- Ψ **O problema não é a proposta, é o uso.** A preocupação declarada não é com o modelo, e sim com o que se fará dele — a mesma lógica da peneira: ela não é boa nem ruim, depende de como se usa.
- Ψ **Individualizar dificulta mensurar.** Quanto mais idiográfico o tratamento, mais difícil avaliá-lo pelos métodos disponíveis, que se baseiam em médias e desvios. O risco é a ciência ser flexibilizada para acomodar a proposta.

Ψ **O contexto brasileiro agrava.** Num país onde o letramento científico é frágil e a prática baseada em evidências ainda não amadureceu, a individualização proposta corre o risco de virar “vale tudo”. A ressalva que ela fez questão de registrar: nada disso é rejeição ao modelo, que considera interessante. É exigência de dados — e a mesma que faria a qualquer outra proposta, incluindo as que já usa.

A posição do mediador

- Ψ **A TBP não substitui modelo estrutural nem diagnóstico.** Ela oferece um **modelo de raciocínio clínico**, e o raciocínio precisa de uma base empírica por trás — diagnóstica, transdiagnóstica ou psicopatológica.
- Ψ **As técnicas não são novas.** Tudo o que a TBP utiliza já é empiricamente sustentado por outros modelos, o que reduz o que precisaria ser testado do zero.
- Ψ **O problema é a dicotomia.** “Fim do diagnóstico” é leitura equivocada, e nasce da mesma dificuldade que produz outras falsas oposições no campo.

Onde a evidência está hoje, para este domínio

Vale acrescentar o que a discussão não explicitou. Para transtornos alimentares especificamente, o suporte empírico mais forte continua sendo a **TCC transdiagnóstica** em adultos (Fairburn et al., 2009) e o **tratamento baseado na família** em adolescentes (Lock & Le Grange, 2013), ambos recomendados em diretrizes internacionais (NICE, 2017).

Isso não invalida o uso da TBP como organizador de raciocínio — é exatamente o que se defendeu na discussão. Mas define o lugar de cada coisa: **o raciocínio pode ser processual; o tratamento indicado permanece o que tem ensaio por trás.**

Houve ainda uma crítica de forma, apresentada como opinião pessoal e acompanhada de reconhecimento explícito da contribuição do autor: a de que a TBP organiza e renomeia, em linguagem mais complexa, conceitos que já existiam. É uma crítica que se faz a várias sínteses influentes na história do campo, e que não decide a questão empírica — mas ajuda a ler o modelo com menos deslumbramento.

O que fica do formato da discussão

Um ponto foi feito por ambos e vale para além do tema: **discordar de uma ideia não é atacar quem a defende**. No ambiente acadêmico, arguição dura sobre um trabalho é procedimento, não hostilidade — e quem não passou por esse ambiente costuma ler a divergência como conflito pessoal. Manter espaços onde se pode discordar tecnicamente é condição para a área crescer.

Referências

1. American Psychiatric Association. (2022). *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR* (5ª ed., texto revisado). Artmed.
2. Arcelus, J., Mitchell, A. J., Wales, J., & Nielsen, S. (2011). Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders: A meta-analysis of 36 studies. *Archives of General Psychiatry*, 68(7), 724–731.
3. Cassin, S. E., & von Ranson, K. M. (2005). Personality and eating disorders: A decade in review. *Clinical Psychology Review*, 25(7), 895–916.
4. Fairburn, C. G. (2008). *Cognitive behavior therapy and eating disorders*. Guilford Press.
5. Fairburn, C. G., Cooper, Z., & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: A “transdiagnostic” theory and treatment. *Behaviour Research and Therapy*, 41(5), 509–528.
6. Fairburn, C. G., Cooper, Z., Doll, H. A., et al. (2009). Transdiagnostic cognitive-behavioral therapy for patients with eating disorders: A two-site trial with 60-week follow-up. *American Journal of Psychiatry*, 166(3), 311–319.
7. Hayes, S. C., Hofmann, S. G., & Ciarrochi, J. (2020). A process-based approach to psychological diagnosis and treatment. *Clinical Psychology Review*, 82, 101908.
8. Holland, G., & Tiggemann, M. (2016). A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes. *Body Image*, 17, 100–110.
9. Hudson, J. I., Hiripi, E., Pope, H. G., & Kessler, R. C. (2007). The prevalence and correlates of eating disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Biological Psychiatry*, 61(3), 348–358.
10. Lock, J., & Le Grange, D. (2013). *Treatment manual for anorexia nervosa: A family-based approach* (2ª ed.). Guilford Press.
11. National Institute for Health and Care Excellence. (2017). *Eating disorders: Recognition and treatment* (NICE guideline NG69).
12. Shafran, R., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (2002). Clinical perfectionism: A cognitive-behavioural analysis. *Behaviour Research and Therapy*, 40(7), 773–791.
13. Sullivan, P. F. (1995). Mortality in anorexia nervosa. *American Journal of Psychiatry*, 152(7), 1073–1074.

NOTA DE MÉTODO

Material de estudo dirigido a psicólogos. Os casos citados em aula estão desidentificados, incluindo o relato de desfecho catastrófico associado a uso de anoréxico, apresentado sem nome de substância nem detalhes do episódio.

Omissões deliberadas. Não foram reproduzidos: pontos de corte de IMC e limiares de gravidade, a operacionalização calórica de episódio compulsivo, nomes comerciais de medicamentos usados como método compensatório ou anoréxico, protocolos de pesagem, números de refeições como critério de alta, e a descrição passo a passo de como a restrição é ocultada da família. Todo esse conteúdo está disponível no DSM-5-TR e na literatura técnica para quem precisa dele profissionalmente; num material aberto, funcionaria como instrução operacional para quem está adoecendo. Nenhum ponto do raciocínio clínico se perde com a omissão — apenas o detalhe que não é necessário para aprender.

Uma precisão empírica. A afirmação de mortalidade de até 10% na anorexia vem de estudos mais antigos; a síntese contemporânea expressa o risco como razão de mortalidade padronizada, cerca de seis vezes a esperada para a idade (Arcelus et al., 2011). O ponto de fundo — maior mortalidade entre os transtornos mentais — permanece.

Um acréscimo ao debate final. Para transtornos alimentares especificamente, o suporte empírico mais forte segue sendo a TCC transdiagnóstica em adultos e o tratamento baseado na família em adolescentes, ambos recomendados em diretrizes internacionais. Isso não contradiz o argumento de que a TBP opera como modelo de raciocínio; delimita o lugar de cada coisa.

Corrigi artefatos de transcrição em nomes próprios: *Famborn* → **Fairburn**; *ara Cooper* → **Zafra Cooper**; *Reis* → **Hayes**; *Hoffman* → **Hofmann**. Os assuntos operacionais e as conversas laterais do encontro foram omitidos. As referências foram acrescentadas para dar respaldo formal a afirmações feitas sem citação explícita; nenhuma citação foi construída para preencher lacuna.

Levar para a prática

Marque conforme experimentar em sessão — e salve o PDF para acompanhar.

- ☐ Investiguei a preocupação com peso e forma corporal antes de aceitar um diagnóstico que chegou pronto.
- ☐ Rastreei depressão e ansiedade em todo paciente que preencheu critérios para os três quadros.
- ☐ Investiguei uso de substâncias com efeito sobre o apetite.
- ☐ Considerei o território do comer transtornado em vez de descartar quem não preenche critérios.
- ☐ Olhei os quatro processos do modelo transdiagnóstico, e não só o comportamento alimentar.
- ☐ Fiz psicoeducação com a família sobre comentários a respeito do corpo.
- ☐ Alinhei expectativas de tratamento com paciente e família — inclusive sobre o que não vai mudar.
- ☐ Comecei a trabalhar prevenção de recaída desde as primeiras sessões.
- ☐ Estabeleci critérios objetivos de alta, e não apenas impressão clínica.

MINHAS ANOTAÇÕES — O QUE LEVO PARA A CLÍNICA

Para revisar — resposta

Responda com suas palavras. O PDF guarda o que você escrever.

1. Qual a diferença prática entre transtorno alimentar e comer transtornado? Que paciente seu está no segundo grupo?

2. Por que a distorção da imagem corporal é o critério que decide o diagnóstico diferencial?

3. Explique, com suas palavras, por que a reestruturação cognitiva clássica costuma emperrar na anorexia.

4. Descreva os quatro processos do modelo transdiagnóstico usando um caso seu.

5. Como você abordaria a família de um paciente sobre comentários a respeito do corpo?

6. Que expectativa de tratamento você precisaria alinhar hoje com um paciente seu — e o que ele espera que não vai acontecer?

7. Como você trabalharia prevenção de recaída desde a terceira sessão, e não na última?

8. Onde você situa a TBP: raciocínio clínico ou tratamento? O que muda na sua prática conforme a resposta?